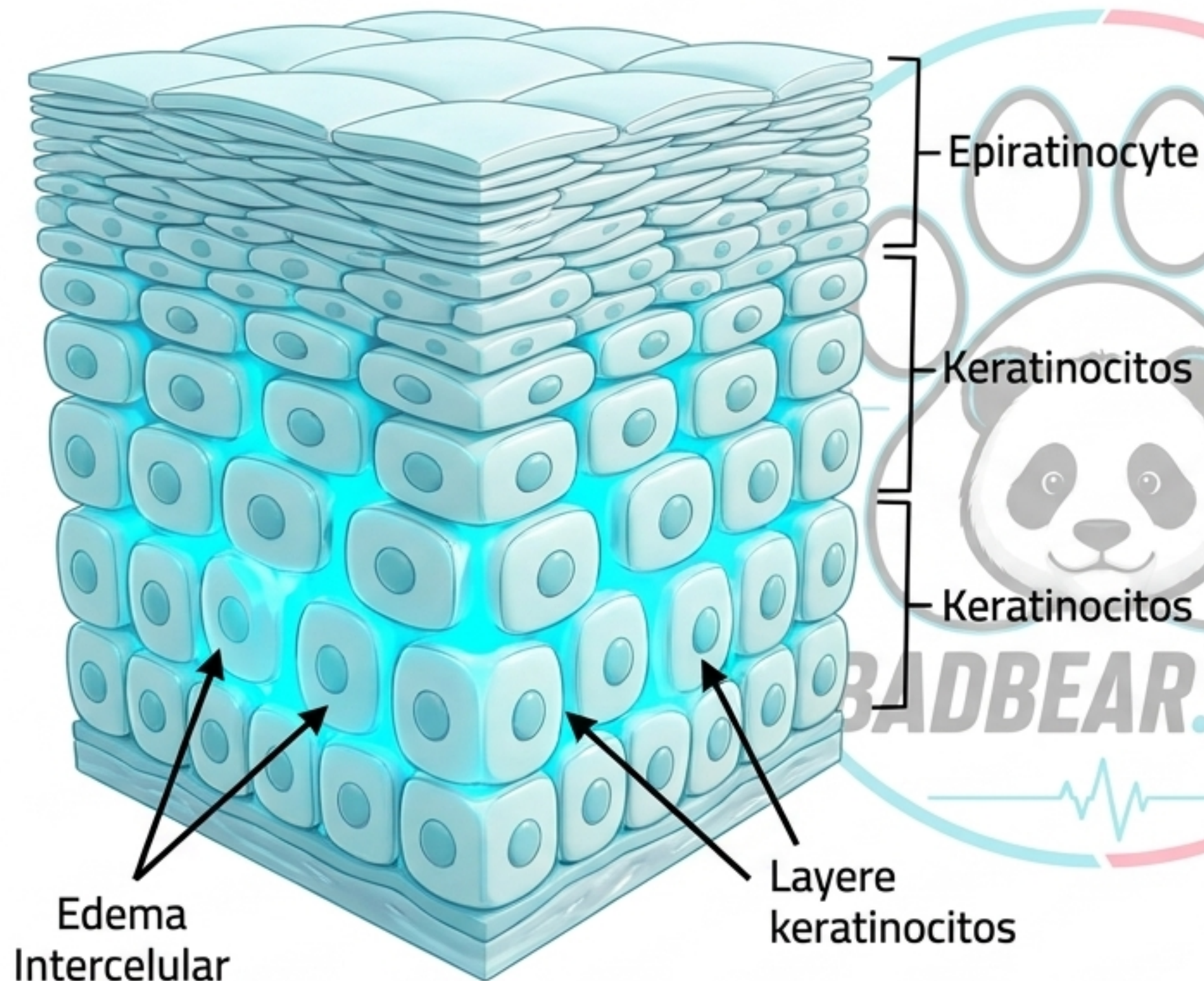


ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PIEL



Guía Clínica y Diagnóstica Diferencial de los Eccemas (Contacto, Atópica y Seborreica)

¿Qué estamos viendo? Fundamentos del Eccema



Deriva del griego **Ekzema** ("ebullición hacia afuera"). Es una respuesta inflamatoria cutánea, polimorfa y altamente pruriginosa.

Espongiosis: Edema intercelular en la epidermis (separación de queratinocitos), hinchándose como una esponja.

La biopsia **NO** diferencia el tipo de eccema. El diagnóstico es puramente **CLÍNICO** (ubicación, tiempo y evolución).

La línea de tiempo evolutiva: De la fase exudativa a la liquenificación



Aguda (Húmeda/Exudativa)

Eritema, pápulas, vesículas.
Ruptura = exudado (piel
mojada/macerada). Predomina el
dolor tipo urente.



Subaguda (Transición)

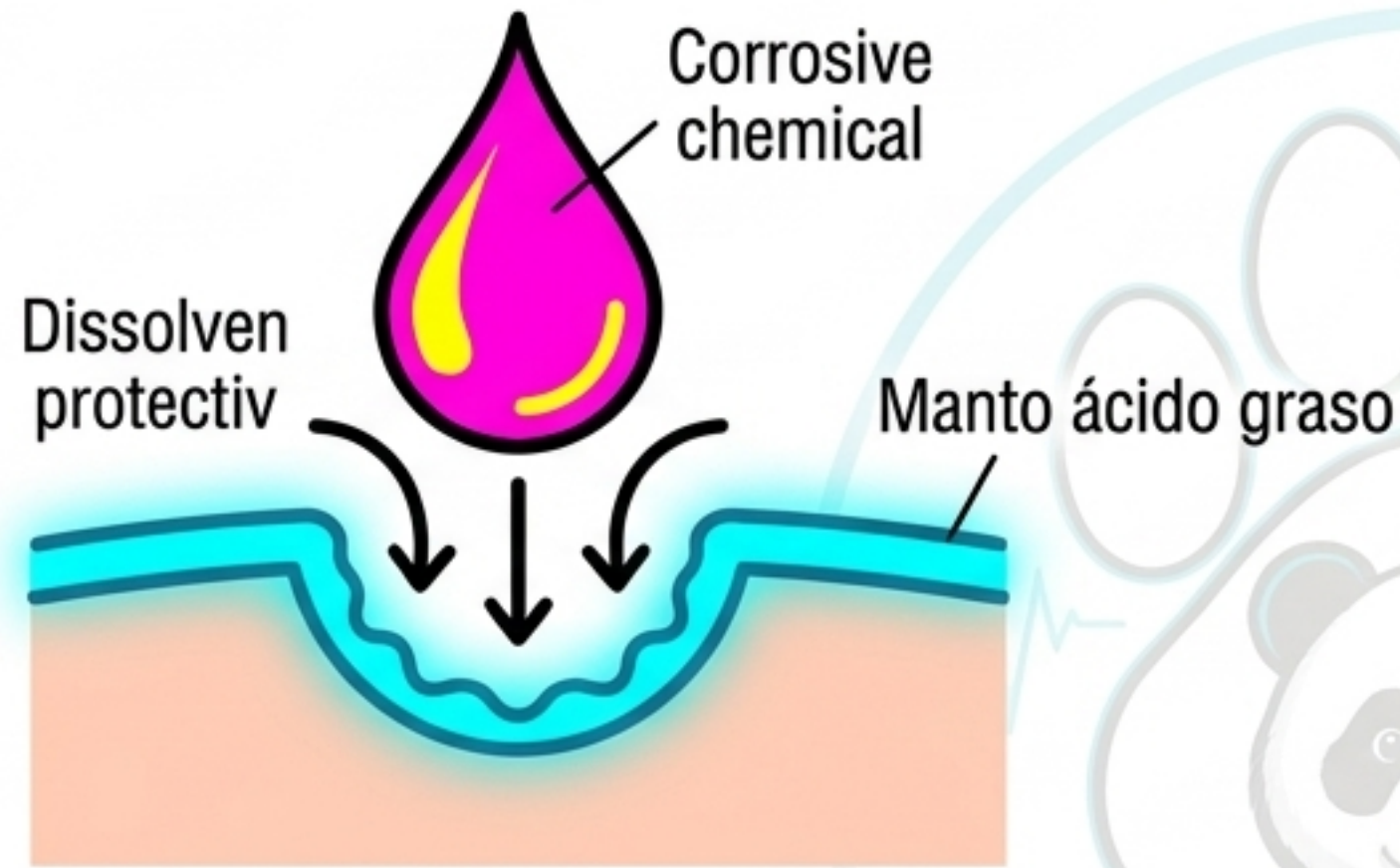
Pápulas, erosiones, costras y
escamas. Signos iniciales de
engrosamiento.



Crónica (Seca/Gruesa)

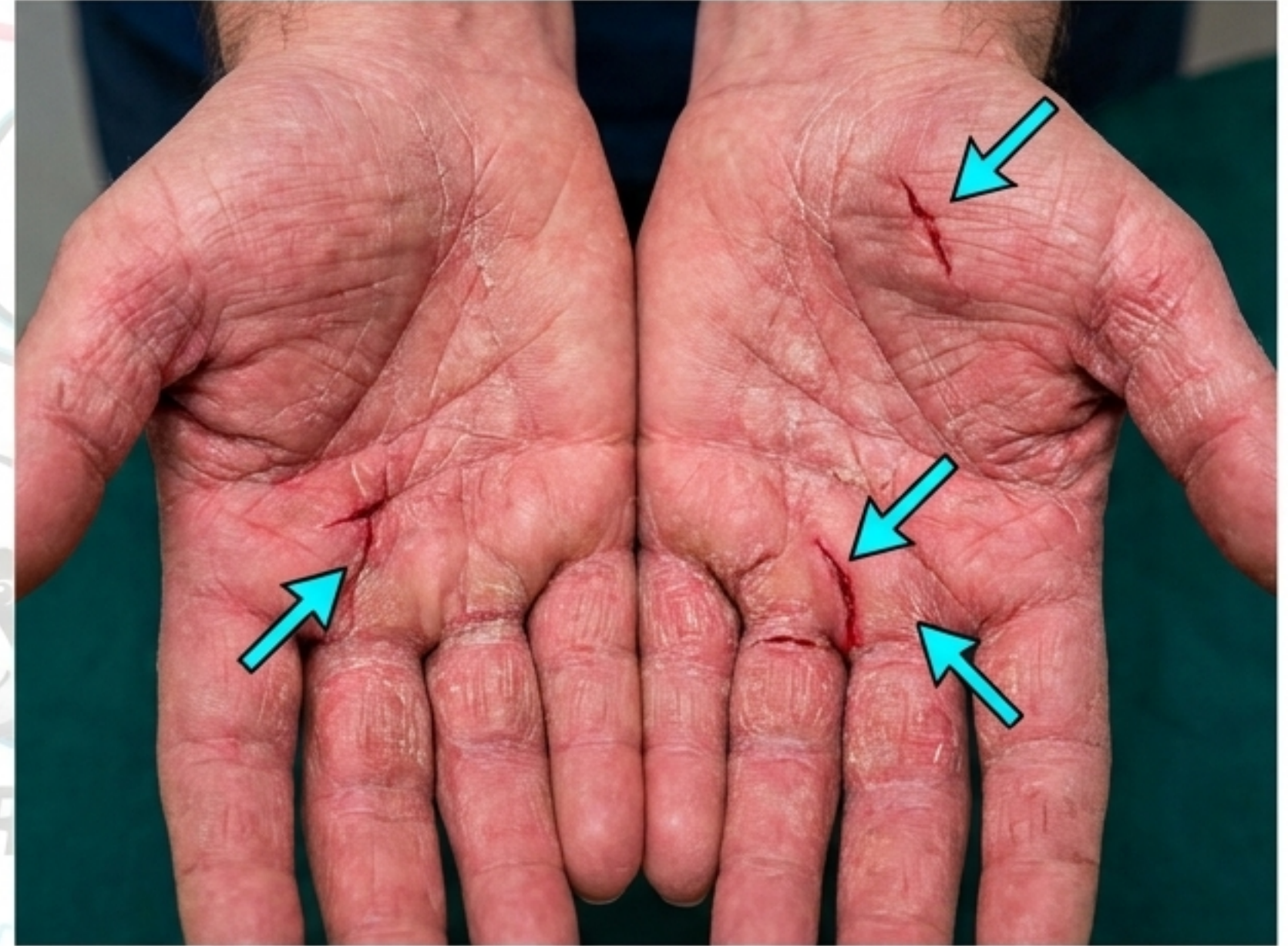
Liquenificación (engrosamiento
epidérmico marcado por el rascado
continuo crónico), hiperpigmentación,
fisuras. Predomina el prurito intenso.

Dermatitis de Contacto Irritativa (DCI): Daño tisular directo



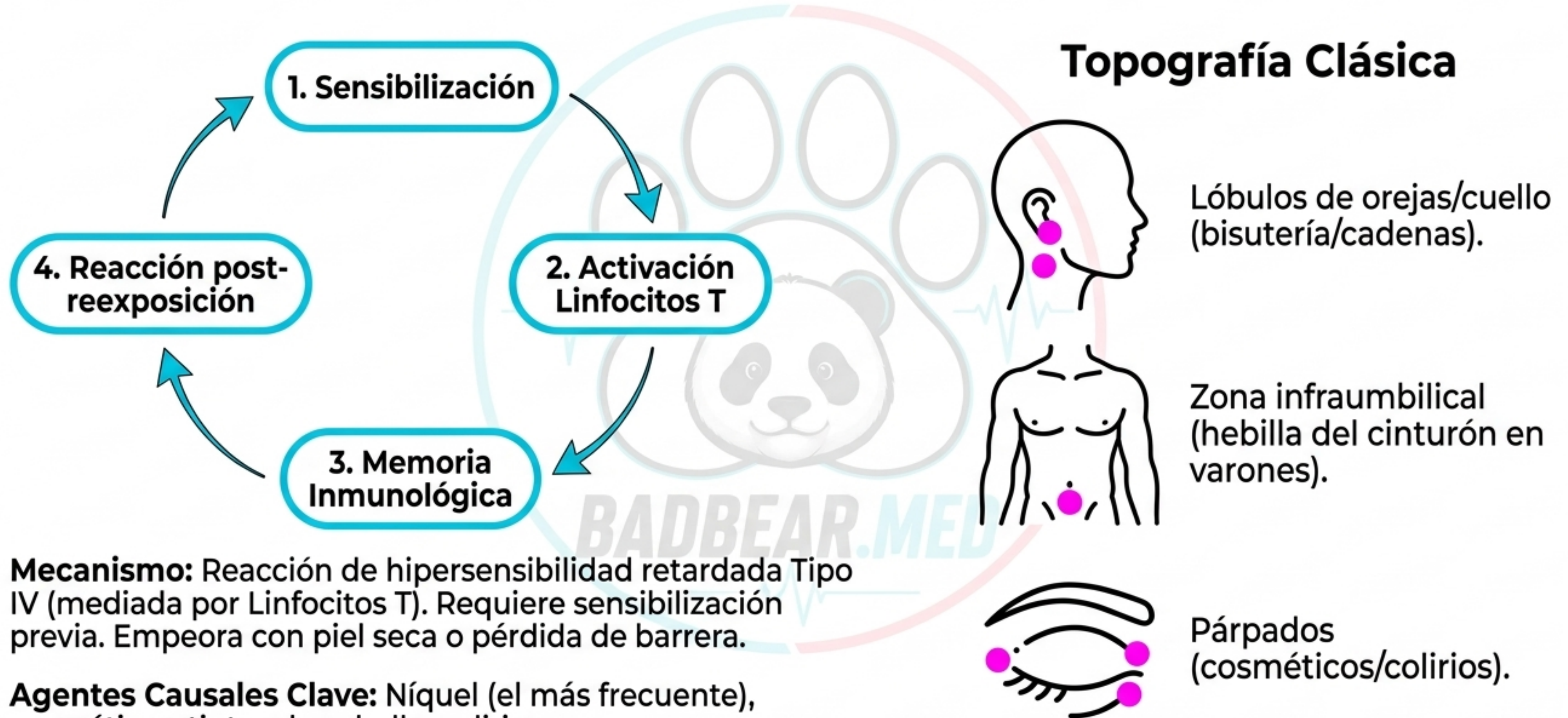
Mecanismo: Destrucción del manto ácido graso. No mediado por inmunología. Depende del tiempo y concentración del agente. NO requiere sensibilización previa.

Agentes Causales: Ácidos, lejía, detergentes, disolventes, alcohol en gel. En niños: uso excesivo de plastilina o slime. Fricción continua o frío/calor extremo.



Clínica Topográfica: Daño limitado estrictamente al área de contacto (ej. manos de mecánicos, carpinteros, pintores). En fase crónica presenta liquenificación dolorosa y fisuras con ardor persistente.

Dermatitis de Contacto Alérgica (DCA): La memoria inmunológica



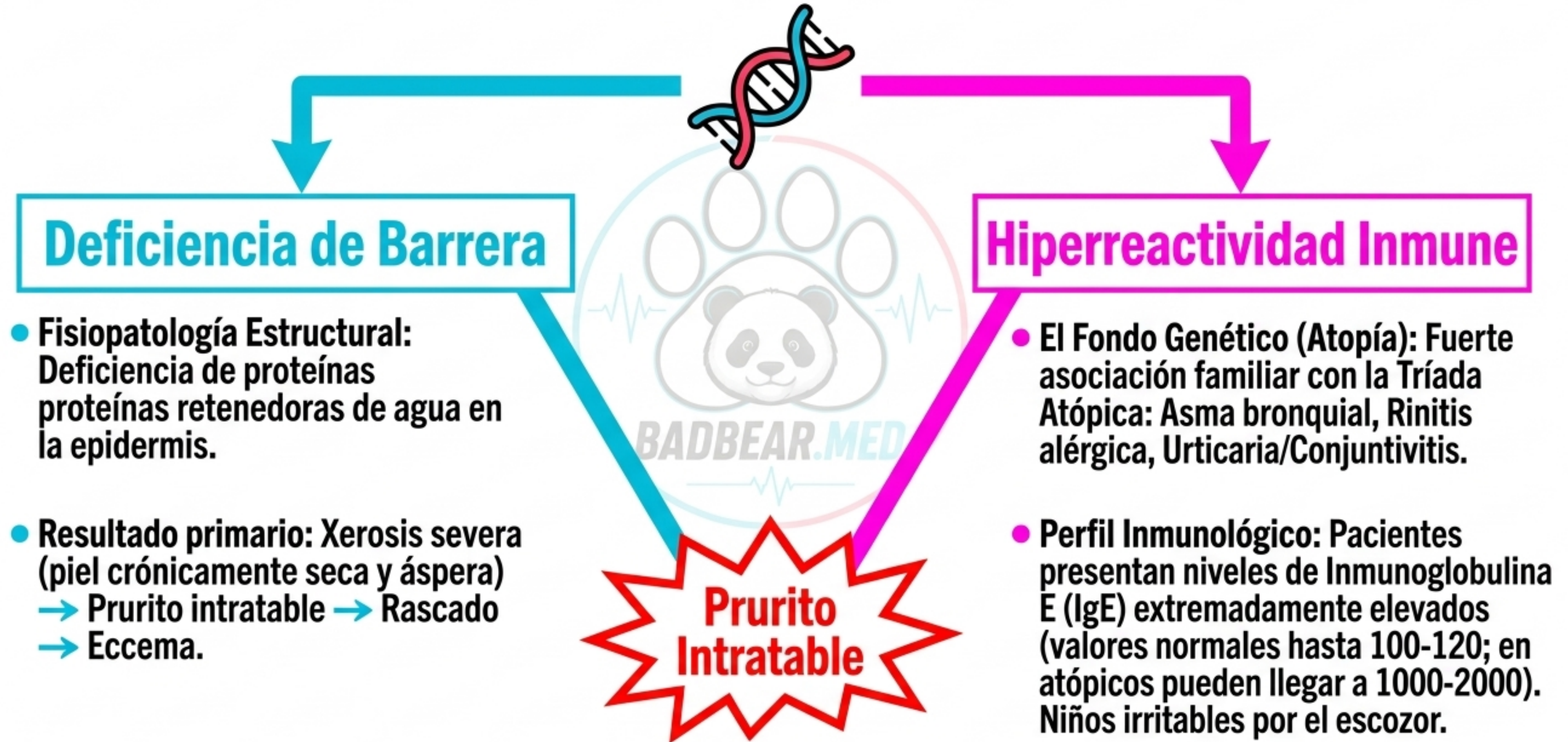
Mecanismo: Reacción de hipersensibilidad retardada Tipo IV (mediada por Linfocitos T). Requiere sensibilización previa. Empeora con piel seca o pérdida de barrera.

Agentes Causales Clave: Níquel (el más frecuente), cosméticos, tintes de cabello, colirios.

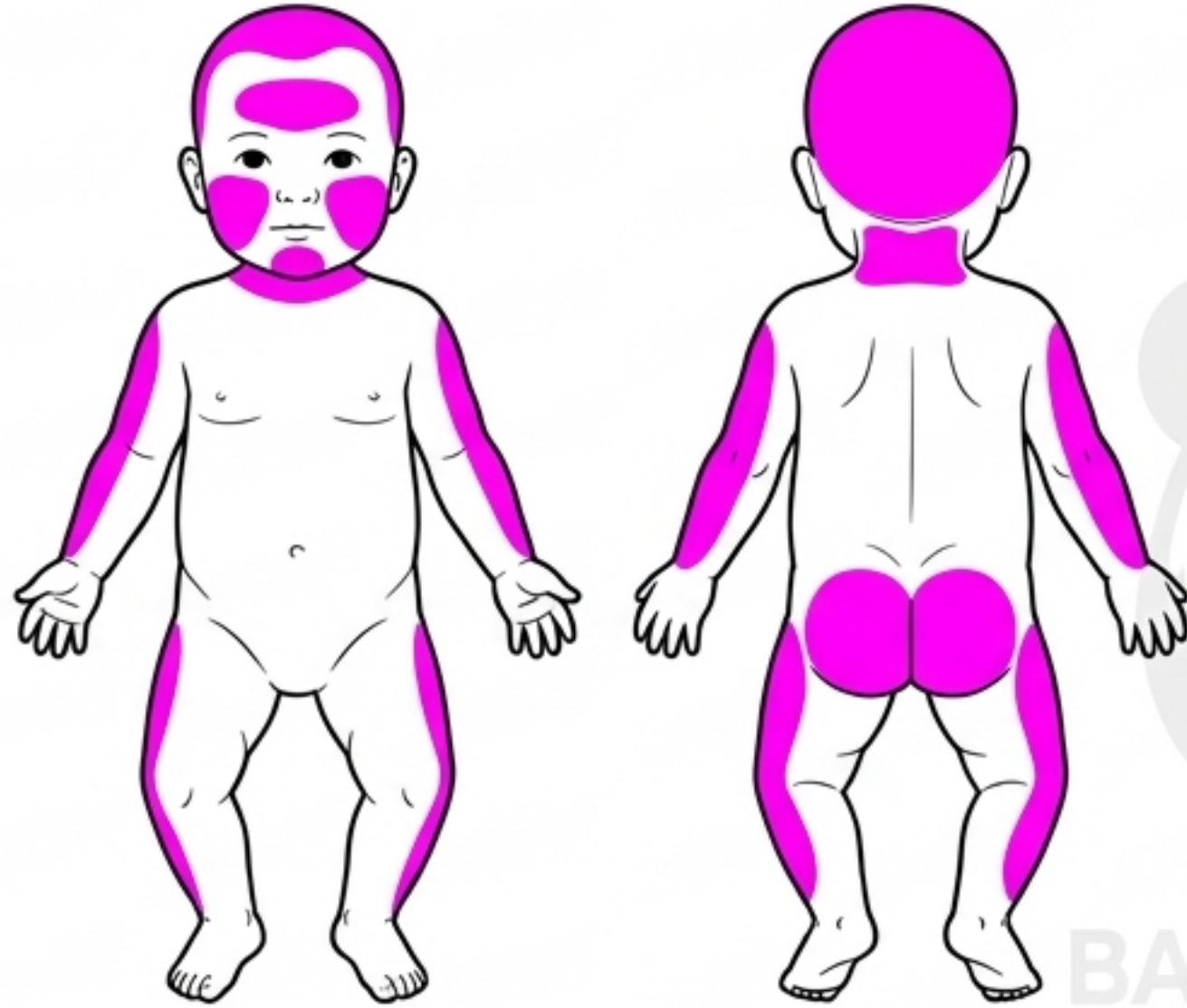
Matriz Diferencial: Irritativa vs. Alérgica

	Dermatitis Irritativa (DCI)	Dermatitis Alérgica (DCA)
Inmunología	No mediada (daño directo de barrera)	Hipersensibilidad Tipo IV (Linfocitos T)
Sensibilización	No necesaria (ocurre al primer contacto fuerte)	Obligatoria (requiere contactos previos)
Velocidad de Reacción	Inmediata a retardada (según la concentración del químico)	48-72 horas post-reexposición al alérgeno
Síntoma Predominante	Ardor, dolor (tipo urente)	Prurito intenso
Evolución	Puede curar completamente si se evita el agente	Sensibilización de por vida (crónica recidivante)

Dermatitis Atópica (DA): Fisiopatología y la tríada genética



Topografía Atópica del Lactante (0 a 2 años)



Zonas de Afectación Primaria: Cara (mejillas, mentón, frente), cuero cabelludo, cuello y superficies extensoras de brazos y piernas, glúteos.

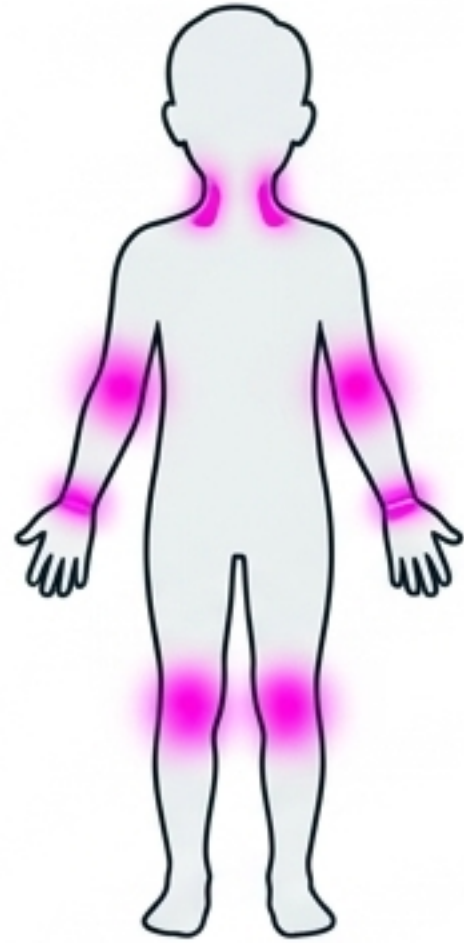
Lesiones mayormente agudas/subagudas (bebés "chapositos").

Nota Clínica: No hay liquenificación severa aún, ya que el lactante no coordina el rascado profundo sistemático.

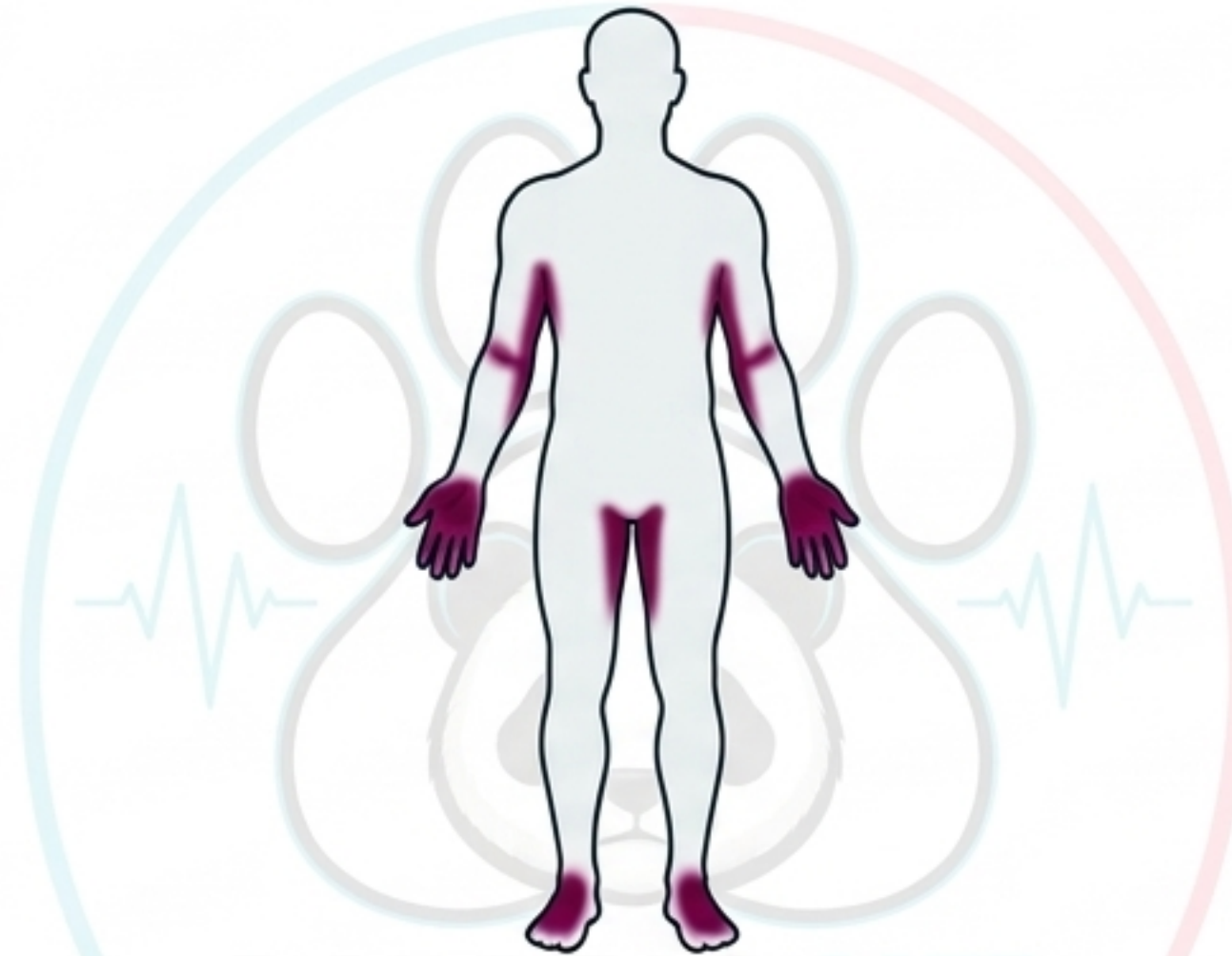


El Signo Diagnóstico de Oro: RESPETA EL TRIÁNGULO CENTROFACIAL.
La zona nasogeniana y el centro de la nariz se mantienen completamente libres de lesiones (piel sana).

La migración atópica: Fase Infantil (2-12a) y Adulto



Fase Infantil (La Inversión): La lesión migra. Afecta característicamente los pliegues de **flexión** (antecubital, (antecubital, poplíteo, flexura de muñeca/pie, laterales del cuello). Inicio de liquenificación franca y escoriaciones.



Fase Adulta (Cronicidad): Placas severamente liquenificadas, gruesas y fisuradas. Afecta dorso de manos/pies y pliegues. Insomnio frecuente por prurito continuo.



Estigmas Periorculares: El rascado crónico de párpados genera hiperpigmentación postinflamatoria printeramnal ('ojeras de panda') y la Línea de Dennie-Morgan (pliegue infraorbitario acentuado).

Dermatitis Seborreica (DS): La inflamación por Malassezia

Concepto Clínico: Es un eccema casi asintomático (prurito leve o nulo). Su impacto es principalmente estético. No es contagioso.

Desencadenantes Exógenos: Climas extremos, cosméticos untuosos/oleosos, uso prolongado de corticoides, jabones alcalinos (detergentes).

Malassezia spp.

Etiopatogenia Central: Respuesta inflamatoria anormal exacerbada por la proliferación del hongo comensal.

Factores Desencadenantes Endógenos: Piel grasa, estrés emocional/fatiga extremos. Altamente prevalente en estados de inmunosupresión (VIH), Parkinson, demencia, esquizofrenia y alcoholismo.

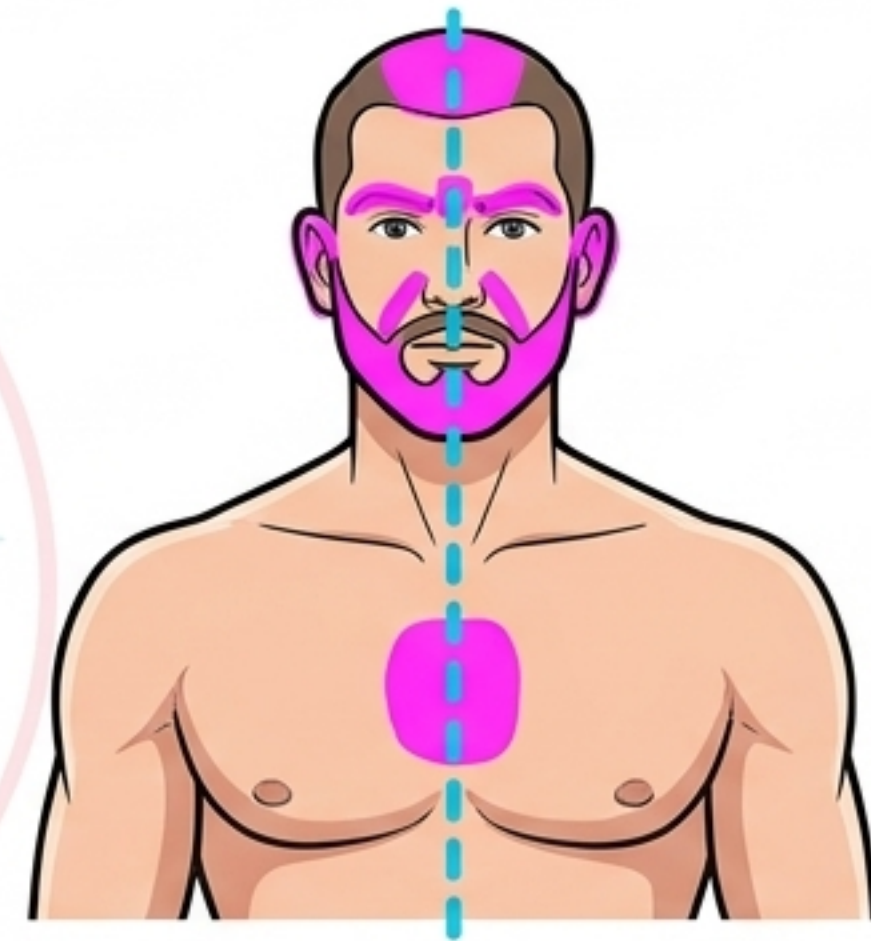
Topografía Seborreica: El dominio de la Línea Media

Lactante



Lactantes (La “Costra Láctea”): Placas amarillentas fuertemente adheridas en cuero cabelludo desde el primer día. Afecta: nuca, oídos, pliegues axilares/inguinales (zona del pañal) y **SÍ AFECTA** el surco nasogeniano.

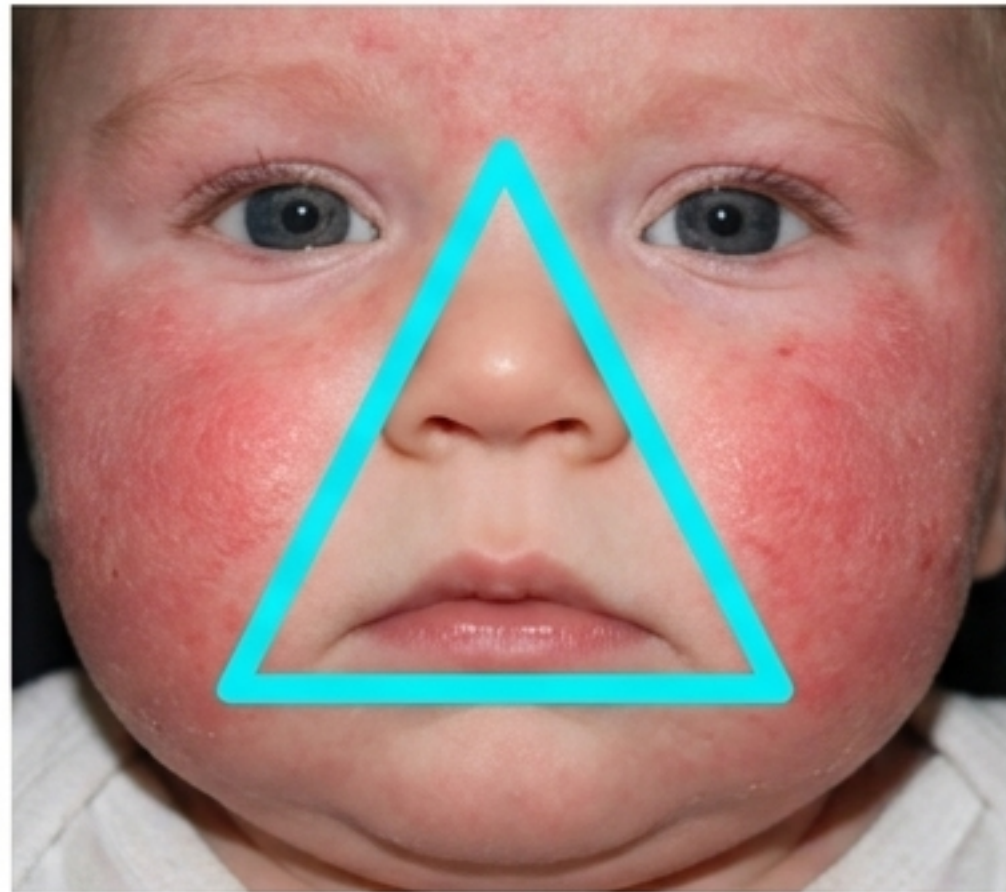
Adulto



Adultos: Placas eritematosas con escamas blanquecinas/amarillentas de aspecto grasoso, muy fáciles de desprender al rascar.

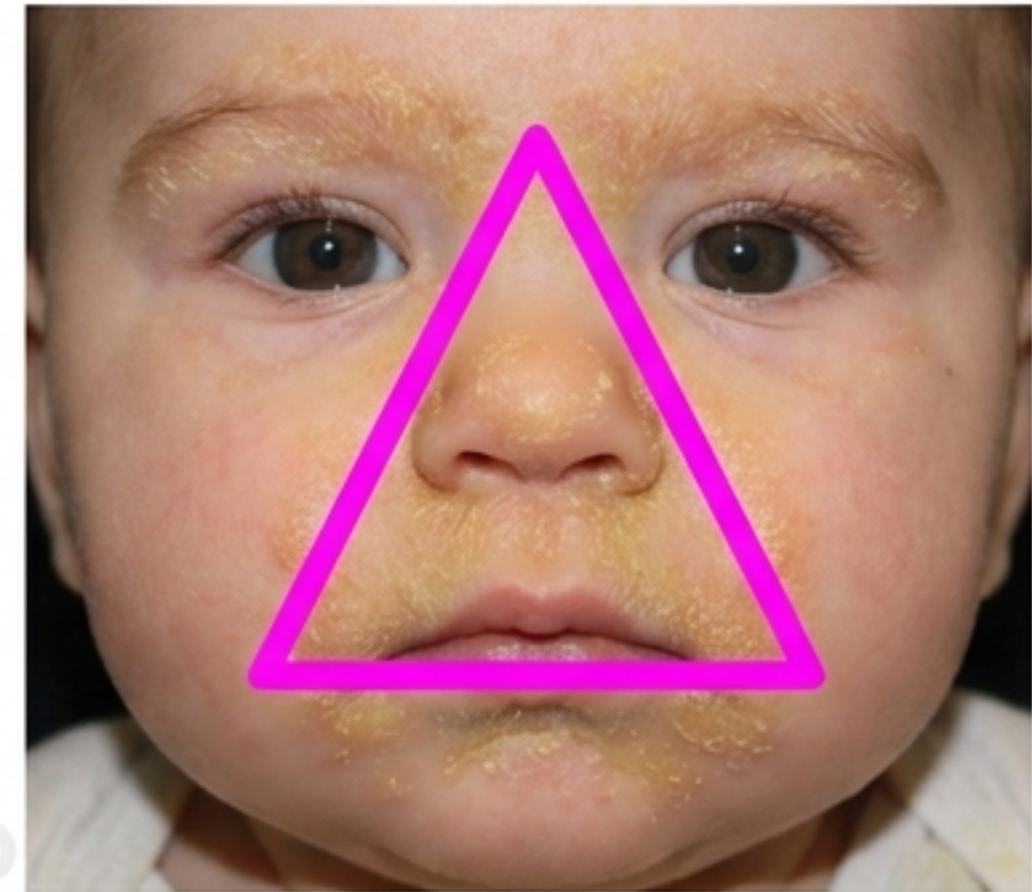
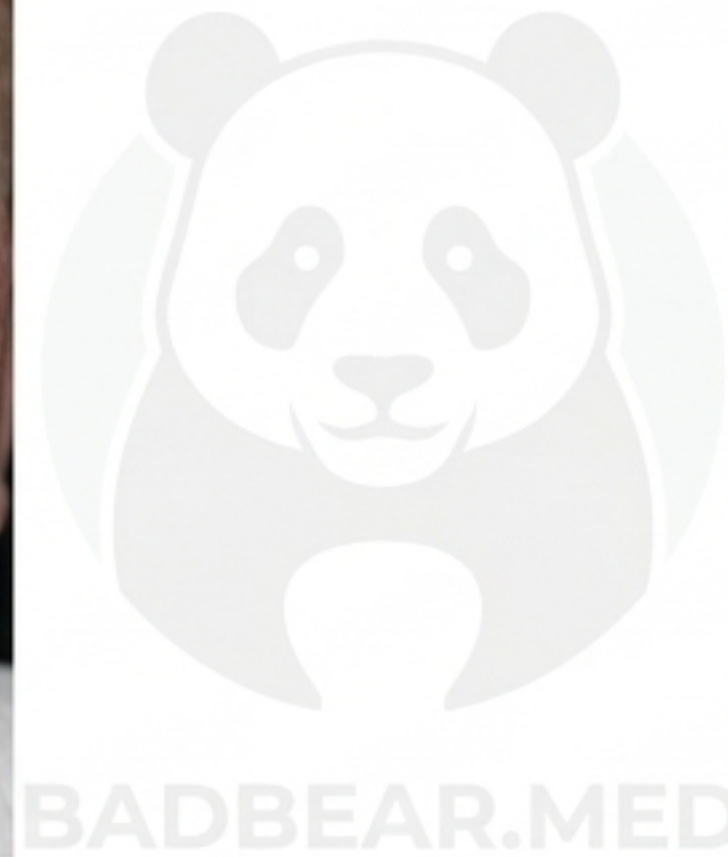
Zonas Clave (Línea Media): Zona centrofacial (entrecejo, cejas, surcos nasogenianos), borde de implantación frontal del cuero cabelludo, orejas/retroauricular, zona de la barba, y zona media anterior del tórax (centro del pecho).

EL GRAN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: El Triángulo de la Verdad



Dermatitis Atópica

- Mejillas eritematosas y secas.
- El triángulo nasogeniano y perioral está **RESPETADO** (piel sana en el centro).
- Prurito extremo, niño irritable.



Dermatitis Seborreica

- Escamas amarillentas/grasientas.
- Afectación directa de la **ZONA CENTROFACIAL** (surco nasogeniano comprometido, junto con cejas y cuero cabelludo).
- **Asintomático** o prurito leve.

El Arsenal Antiinflamatorio: La Escalera de Corticoides



Regla de Oro (Alerta): Uso estrictamente condicional (solo durante brotes hasta que desaparezca la lesión, **NUNCA** continuo). Depende de topografía y edad.



Peldaño 1: Baja Potencia (Lactantes y Cara)

Ideal para piel fina y delicada. Ej:
Hidrocortisona, Desonida,
Metilprednisolona.

Peldaño 2: Mediana Potencia (Niños, Adolescentes, Tronco)

Para placas establecidas. Ej:
Betametasona, Mometasona.

Peldaño 3: Alta Potencia (Adultos, Liquenificación, Palmas/Plantas)

Para piel gruesa (ej. DCI crónica en
manos). Ej: Clobetasol, Triamcinolona.

Terapias Adyuvantes: El manejo más allá de los corticoides



1. Restauración de Barrera (DA y DCI)

Pilar absoluto. Uso de humectantes (Urea) aplicados con la piel semihúmeda post-baño (sella la hidratación). Ácido salicílico si hay placas muy escamosas gruesas.



2. Control Fúngico (Exclusivo DS)

Reducir carga de Malassezia.
Tópicos: Ketoconazol, Piroctona Olamina, Ciclopirox.
Sistémicos (para casos severos o inmunosuprimidos): Fluconazol, Terbinafina.



3. Control de Desencadenantes

Manejo del estrés psicológico (crucial para evitar exacerbaciones seborreicas y atópicas). Reemplazo de jabones alcalinos por sustitutos Syndet.

Conclusiones para la Práctica Clínica

1 Naturaleza Evolutiva

Ninguna de estas patologías se cura, se controlan. Son crónicas y cursan en **brotes oscilantes** (exacerbación y remisión).

2 El Diagnóstico es Soberano

La **biopsia** solo arrojará 'espongiosis'. La **historia clínica** (oficio, hobbies, atopía) y la **topografía** son tus verdaderas herramientas diagnósticas.

3 Leyes Topográficas

- **Atópica** = Extensoras en bebé (respetar centro), Flexuras en niños/adultos.
- **Seborreica** = Línea media y zonas pilosas.
- **Contacto** = Molde exacto del alérgeno o irritante.

4 Eje Terapéutico

Corticoides en escalones según topografía + reparación implacable de la barrera cutánea.